



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض ربيعاً : سحر سيد حسين عيسى
المحافظة : القاهرة
الحى / المدينة : عين شمس
رقم البطاقة : 26912260100847 رقم التليفون : 01117618242
العنوان : ----
العمر (تاريخ الميلاد) : 26-12-1969 المهنة : ربه منزل
تاريخ تسجيل الإستمارة : 01-10-2026

الإقرار

أقر أنا الموقع أدناه أنني لا اتمتع بأي نظام علاج مثل:- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات أو أي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك
الإحصائي الاجتماعي
التوقيع: (-----)
المقرر بما فيه
التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : أبحاث أورام مزيد من الأبحاث و الاشعات [7954] قسم العلاج : الاورام

التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني
الاسم: د/ندى حسن
الاسم: د/نرمين رمضان
الوظيفة: -----
الوظيفة: -----
الوظيفة: -----
التوقيع: -----
التوقيع: -----
التوقيع: -----
أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بأن البيانات المدونة في هذا النموذج صحيحة.
تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة ومدير
المستشفى.

تعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

د. / ----- / د. / ----- / د. / ----- / د. / -----

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : -----
خطة العلاج : -----
المستشفى : -----
قسم : -----
جهة العلاج : -----
نفقات : -----
ملاحظات : -----

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: سحر سيد حسين عيسى National ID: 26912260100847	
--	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريرنا عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Further investigations and imaging

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين



المطابقة سارية حتى ٢٠١٨/١٩/٢١



Name: سحر سيد حسين عيسى		
MR. : 7012		
Detailed Medical Report		
		السيد
تحتية طبية وبعد,,		
	بشأن تقرير طبي للمريض	إيماء للطلب المقدم من
	رقم طبي:	بقسم:
ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته		
	تاريخ وساعة الخروج :	تاريخ وساعة الدخول :
وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه		
FEMARA CALCIUM 1*1*90 ONE ALPHA FOR CT CAP BREAST US FULL LAB.		
FOR FEMARA AND SUPPORTIVE TTT CT CAP >> left breast microcalcifications for SM left illiac bony island for bone scan.		
5/2026 sm :free 6/2026 bone scan :free femara +supportive*3m next clinic visit :21/09/2026.		
تحريرا في ,		
	التاريخ :	20-09-2026
	الوقت :	
	إيه مدحت بدوي محمد	الطبيب المعالج :
يعتمد ,		

MDT FORM

24/ 8 / 2025 G

Name	لتر سيد حسين	MRN	1772/2020
Age	55 yrs	ID	
Menopausal status	postmenopausal	Phone	01005637183
NRS SCORE		Marital status	single
BMI		Family history	-ve Family h
CO morbidity	D, HTN	REASON OF MDT	New MDT
-ve for operation except lt BCS.			

Clinical Data

BX:	IDC II	R	L
ER:	PR:	HER 2:	KI67:
7/8	6/8	+2 not amplif.	10-15%
Sonomammography:			
Mets Workup:			

TNM

Recommendations: lt breast Ca IN 2020 Exsion
of lt breast Mass was done then (upfront BCS)
out side harmel pT2 No then Received Adj
chemotherapy + PORT For she on Adihormonal AL
For 4yrs till New for New MDT

MDT OUTCOME & PLAN

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY	Nutrition	Psychiatric

Dr.
Soliman Saba
M.Sc., M.D. Pathology
Prof. Of Pathology
Faculty of Medicine, Cairo University
Fellow, Ohio State University U.S.A.

دكتور
سليمان سابا
أستاذ الباثولوجيا
كلية طب قصر العيني
زميل جامعة أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية

Name: **استاذ سيد محمد حسين عيسى**

Age: 49 years

Clinical Diagnosis: Left breast U.O.Q mass.

Nature of specimen: Excision biopsy.

Referred By : Prof. Dr. ABDEL-FATTAH RIZK.

Date: 26/04/2020

PATHOLOGY REPORT

GROSS: Specimen received consists of a lump measuring 6.5x4.5x3.5 cm and showing on cut section a gritty yellowish white mass measuring 1.2x1 cm. Surgical margins are free; the narrowest being 1.5 cm. Multiple separate pieces of tissue were also received; the largest measuring 2.5x1.8x0.8 cm with firm grayish white circumscribed cut section.



MICROSCOPIC: Serial sections examined from the specimen received revealed an ill-defined mass formed of infiltrating groups of moderately pleomorphic malignant ductal epithelial cells showing high nucleo/cytoplasmic ratio, hyperchromatic or vesicular nuclei with prominent nucleoli and moderate mitotic activity. Focal areas of tubular differentiation were detected. There are also dilated ducts lined by malignant epithelial cells arranged in cribriform pattern with evidence of occasional central necrosis (DCIS constituting about 10% of the tumour mass). The stroma separating tumour groups is moderately desmoplastic. Few lymphatic tumour emboli were detected. The surrounding breast tissue revealed focal adenosis, dilated blunt ducts (entangling microcalcifications) and microcysts lined by cubical epithelial cells showing evidence of apocrine metaplasia. The intervening stroma is fibrotic. Sections of the largest separate piece revealed a well circumscribed mass surrounded by a fibrous capsule and formed of both rounded and elongated compressed glands lined by double cell layer; inner cubical and outer myoepithelial. The intervening stroma is fibrotic hyalinized. Surgical margins are free. No evidence of blood vessel invasion by tumour tissue.

DIAGNOSIS: Left breast mass, Excision biopsy, Infiltrating Duct Carcinoma, Grade II, T1 Associated With DCIS Grade II On Top Of Fibrocystic Disease. Associated Fibroadenoma, Mixed Intra- And Pericanalicular Type. Free Surgical Margins.

Thanks for reference,

Copy *[Signature]*

ميدان التحرير - 2 شارع طلعت حرب - الدور الثالث ت: 25749601

5/5/2020
1 ميدان التحرير - الدور الأول - الدواى - ت: 25254562



أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مركز أورام دار السلام
"هرمل مباحث"

Patient name: Sahar Sayed Hussein

Date: 17/8/2020

Combined Bilateral Breasts Mammography and complementary ultrasound

Indications:

Regarding the newly added information on 29/8/2020 that the fore mentioned patient had left breast CBS (with free surgical margins) on 4/2020 and on post operative chemotherapy.

Technique:

Bilateral MLO and CC views

Complementary ultrasound

Report:

- The breasts are heterogeneously dense which may obscure small lesions (ACR C)
- Left breast UOQ focal area of parenchymal distortion owing to prior surgical interference, with no suspicious calcifications.
- Complementary ultrasound in comparison to prior study dated 10/5/2020 revealed:
 - Left breast 12 to 1 o'clock para-areolar focal area of parenchymal distortion owing to prior surgical interference with no evidence of recurrent mass lesions, with small cystic lesion with hyper echoic content seen at the medial aspect of the scar, with no vascularity detected within on color Doppler, measuring 4x8mm (was 15x43mm), of regressive course in comparison to prior study dated 10/5/2020, likely post operative sequel.
- Normal right breast with no suspicious solid or cystic mass lesions
- Non specific axillary LNs, bilaterally.

Opinion:

- Left breast UOQ focal area of parenchymal distortion owing to prior surgical interference, with normal postoperative changes with no evidence of residual or recurrent mass lesions.
- Right breast benign findings
- BIRADS 2.

Yours truly
Dr Engy Abdullah

Name : Sahar Sayed

Date : 31/5/2020

**POST CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST,
ABDOMEN & PELVIS REVEALED: -**

Known case of breast cancer.

1. Chest:

- Focal left breast skin thickening is noted with left breast marked parenchymal distortion.
- No sizable pulmonary nodules, masses, areas of consolidation or cavitary lesions.
- Prominent right para-tracheal lymph node.
- No hilar lymph nodes.
- No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
- Normal cardiac size. No pericardial effusion detected.
- Normal CT appearance of the thoracic aorta and the great vessels.
- Normal appearance of the dorsal vertebrae.

2. Abdomen and pelvis:

- The liver is of average size with homogenous low CT texture. No focal lesions or contour irregularities.
- Patent homogeneously enhancing portal vein and its main branches as well as its main tributaries.
- No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
- Normal size & parenchymal texture of the spleen with no focal lesions seen.
- Normal size, parenchymal thickness & density of both kidneys with no stones or back-pressure changes.
- Normal appearance of the pancreas, aorta, I.V.C and both suprarenals.
- Smooth filling of the urinary bladder with no filling defects or diverticular outpouching.
- Normal appearance of the other pelvic organs.
- No abdominal or pelvic collections.
- No destructive bony lesion could be seen

OPINION:

- ***Known case of breast cancer showing left breast parenchymal distortion.***
- ***Fatty liver.***
- ***No hepatic or pulmonary deposits.***

Dr. Ahmed M. Rozeka, MSc

Dr.m.gomaa.md